

MEDULA AGUDA — RM URGENTE, TEMPO É FUNÇÃO

SÍNDROME MEDULAR — RECONHECIMENTO

Achado	Significado
Nível sensitivo	Hipoestesia abaixo de um dermatomo (marca do nível da lesão)
Paraparesia/tetraparesia	Fraqueza simétrica abaixo da lesão; cervical = membros superiores e inferiores
Disfunção esfincteriana	Retenção/incontinência urinária e fecal — sinal de alarme
Dor	Dorsal/cervical, piora ao deitar (compressão neoplásica)
Padrão	Lesão completa vs incompleta; síndrome de Brown-Sequard, centromedular, cordão anterior
Choque medular	Fase inicial com arreflexia e flacidez, depois espasticidade

PRINCIPAIS CAUSAS NÃO-TRAUMÁTICAS

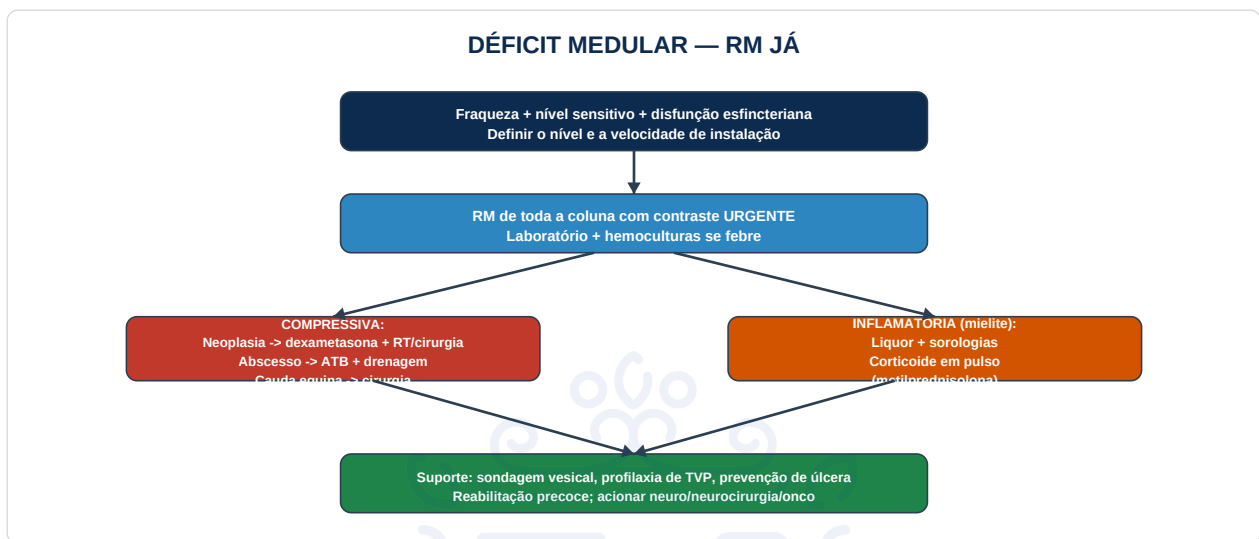
Grupo	Causas	Pista
Compressiva	Metástase epidural, abscesso epidural, hematoma, hérnia discal, espondilodiscite	Dor + déficit progressivo; emergência cirúrgica
Inflamatória (mielite)	Esclerose múltipla, neuromielite óptica, ADEM, pós-infecciosa	Instalação em horas-dias, RM com hipersinal
Infecciosa	Abscesso epidural (S. aureus), HIV, HTLV, herpes, esquistossomose	Febre, dor, fatores de risco (usuário de drogas IV, imunossupressão)
Vascular	Infarto medular (artéria espinhal anterior)	Início súbito, dor, preservação da propriocepção
Neoplásica	Compressão por tumor vertebral/epidural; tumor intramedular	Câncer conhecido; dor que piora deitado
Cauda equina	Hérnia discal volumosa, tumor	Anestesia em sela, retenção urinária, déficit assimétrico

EMERGÊNCIA TEMPO-DEPENDENTE

RM URGENTE DE TODA A COLUNA + STATUS NEUROLÓGICO PRÉ-TRATAMENTO É O QUE DEFINE O PROGNÓSTICO

- Déficit medular agudo = emergência: o status neurológico ANTES do tratamento é o principal preditor de recuperação
- RM de TODA a coluna com contraste é o exame de escolha (urgente)
- Compressão por neoplasia: dexametasona IMEDIATA + RT/cirurgia (ver protocolo de compressão medular neoplásica)
- Abscesso epidural: antibiótico + drenagem cirúrgica urgente; hemoculturas antes do ATB
- Cauda equina (anestesia em sela + retenção): cirurgia descompressiva de urgência
- Não aguardar para confirmar o diagnóstico exato se há déficit progressivo — agir e acionar a especialidade

ABORDAGEM DA SÍNDROME MEDULAR AGUDA



MIELITE E ABSCESSO EPIDURAL

Mielite Transversa

- Inflamação medular: déficit motor/sensitivo + disfunção autonômica em horas-dias
- Investigar: RM com gadolínio, líquor (células, proteína, bandas oligoclonais), aquaporina-4 e anti-MOG
- Causas: esclerose múltipla, neuromielite óptica, pós-infecciosa, ADEM, lúpus
- Tratamento: corticoide em pulso (metilprednisolona 1 g/dia 3-5 dias)
- Plasmaférese se refratária ao corticoide
- Excluir compressão antes de assumir causa inflamatória

Abscesso Epidural Espinhal

- Tríade: dor nas costas + febre + déficit neurológico (nem sempre completa)
- Fatores de risco: usuário de drogas IV, diabetes, bacteremia, procedimento espinal
- Agente mais comum: *Staphylococcus aureus*
- RM com contraste é o exame de escolha; hemoculturas antes do ATB
- Tratamento: antibiótico + drenagem/descompressão cirúrgica urgente
- Atraso = paraplegia irreversível

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Reconhecer a síndrome medular: nível sensitivo + fraqueza + disfunção esfincteriana
- ☐ RM de toda a coluna com contraste em caráter de urgência
- ☐ Compressão neoplásica: dexametasona imediata + RT/cirurgia
- ☐ Abscesso epidural: hemoculturas + antibiótico + drenagem cirúrgica urgente
- ☐ Cauda equina (anestesia em sela + retenção): descompressão de urgência
- ☐ Mielite (após excluir compressão): corticoide em pulso; suporte vesical, TVP e reabilitação para todos

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com câncer de próstata e dor dorsal progressiva evolui com paraparesia e retenção urinária. Qual a conduta imediata?

- A) Aguardar RM eletiva e analgesia
- B) Dexametasona imediata + RM de toda a coluna em urgência + acionar RT/neurocirurgia
- C) Fisioterapia e reavaliação ambulatorial
- D) Antibiótico empírico
- E) Punção lombar imediata antes de qualquer imagem

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Usuário de drogas IV com febre, dor lombar intensa e déficit motor progressivo em membros inferiores. Qual a principal hipótese e o exame de escolha?

- A) Hérnia discal — radiografia
- B) Abscesso epidural espinal — RM com contraste
- C) Lombalgia mecânica — repouso
- D) Esclerose múltipla — potencial evocado
- E) Infarto medular — angiografia

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com anestesia em sela, retenção urinária e fraqueza assimétrica de membros inferiores. Qual a síndrome e a conduta?

- A) Síndrome da cauda equina — descompressão cirúrgica de urgência
- B) AVC — trombólise
- C) Mielite leve — alta com corticoide oral
- D) Polineuropatia — observação
- E) Lombalgia — analgesia e alta

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o principal preditor de recuperação funcional nas síndromes medulares compressivas agudas?

- A) A idade do paciente
- B) O status neurológico ANTES do início do tratamento e a precocidade da intervenção
- C) O tipo de tumor
- D) O nível da lesão
- E) O valor da proteína no líquor

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Antes de assumir uma causa inflamatória (mielite) para um déficit medular agudo, o que deve ser obrigatoriamente excluído?

- A) Enxaqueca
- B) Compressão medular (com RM urgente)
- C) Crise convulsiva
- D) Hipoglicemia
- E) Neuropatia periférica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Câncer + dor dorsal progressiva + paraparesia + retenção urinária = compressão medular neoplásica. Conduta imediata: dexametasona (antes mesmo da confirmação) + RM de toda a coluna em urgência + acionar radioterapia/neurocirurgia. O atraso causa paraplegia irreversível.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Usuário de drogas IV com febre + dor lombar + déficit progressivo sugere abscesso epidural espinal (S. aureus o agente mais comum). O exame de escolha é a RM com contraste; hemoculturas antes do antibiótico, seguido de drenagem cirúrgica urgente.

QUESTÃO 3 → Resposta: A

Anestesia em sela + retenção urinária + déficit assimétrico de membros inferiores caracteriza a síndrome da cauda equina, que é emergência: requer RM urgente e descompressão cirúrgica precoce para evitar sequelas esfinterianas e motoras permanentes.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Nas síndromes medulares compressivas, o status neurológico ANTES do tratamento e a rapidez da intervenção são os principais determinantes do prognóstico funcional. Quem chega deambulando tem muito mais chance de manter a marcha se tratado a tempo.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Sempre se deve excluir compressão medular (com RM urgente) antes de assumir uma causa inflamatória (mielite). A compressão é uma emergência cirúrgica tempo-dependente, e tratar como mielite uma compressão retardaria a descompressão.

SM24
Suporte ao Plantão Médico